

TEMA 1.14 • CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA

Anestesia I

PERFIL EUNACOM 4.01.1.026

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Riesgo y Evaluación Preanestésica

El pilar inicial para cualquier intervención general consiste en anticipar la susceptibilidad pre-quirúrgica y evitar el choque orgánico.

Manejo de Fármacos de Uso Crónico

1. **Fármacos a mantener intactos (NO Suspender):** Se respetan las dosis habituales previas de insulinas, hipoglucemiantes orales, estabilizadores hipertensivos, diuréticos y psicotrópicos, con el fin de evitar fluctuaciones desastrosas de la homeostasis de la presión o glicemia. 2. **Fármacos de Retiro Mandatorio (Suspensión Prequirúrgica):** Se anulan universalmente para frenar tasas incontrolables del riesgo hemorrágico del bisturí intraoperatorio. - **Anticoagulantes Orales** (Suspender 5 a 7 días antes o realizar traslapes estrictos con heparinas bajo protocolos cardiovasculares). - **Ácido Acetilsalicílico (Aspirina)** y drogas Antiagregantes. - **Múltiples AINEs** potentes adicionales (retirar al menos 2 a 3 días previo al pabellón, poseen potente antiagregación reversible o parcial cruzada).

Clasificación ASA del Riesgo Físico (American Society of Anesthesiologists)

Esquematiza estadísticamente el riesgo de un evento o morbimortalidad posquirúrgica. - **ASA I:** Paciente joven, sano sin ninguna enfermedad sistémica ni patologías médicas per se. Buen pronóstico integral. - **ASA II:** Enfermedad sistémica y orgánica pero leve o **plenamente compensada sin compromiso general** funcional o limitante (Ej: Asmático asintomático estable, DM II con glucosas en tope sano, Hipertensión Crónica de rango en verde basal, fumador menor). - **ASA III:** Patología sistémica contundente **severa compensada** que interfiere las funciones y limitan orgánicamente o provocan debilidad o daño a un órgano blanco central orgánico preexistente crónico (Ej: DM II rebasada c/ neuropatía y creatininas dispares, IC crónica tratada). - **ASA IV:** Enfermedad sistémica con morbilidad de altísimo grado que representa por sí misma **una amenaza e inminente riesgo vital para la supervivencia a horas de hoy** (Ej: IC masivo severo c/ Edema Agudo de Pulmón cursando grave, IAM menor a 6 meses de inestabilidad activa alta). - **ASA V:** Individuo categorizado "Moribundo crónico/agudo vital extremas" que muy probablemente no logre vivir de acá a un día por sí mismo con o sin la cirugía de pabellón a cuesta, cuya intervención se practica únicamente como "heroica-terminal" (ej. Disección gigante o Aneurisma vascular central masivo reventado). - **ASA VI:** Paciente médicamente catalogado bajo certificación en muerte encefálica / muerte cerebral para preservación donante exclusivo para procuramiento general de órganos limpios.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Precauciones Comórbidas Mayores Pre-quirúrgicas - **Máximo Riesgo Cardiovascular Absoluto EUNACOM: Estenosis Aórtica** (Valvulopatía más inestable del hemodinamismo con inmenso letal desarrollo de isquemias y bradicardias colapso intra peridural). Le sigue muy de corto un **Infarto (IAM) de menos de 6 meses de duración evolutiva** que obliga a diferir cirugías electivas. - **Máximo Riesgo y Disfunción Respiratoria:** Pacientes con Espirometrías diagnosticadas francamente obstructivas severas (EPOC pulmonar irreversible). O cirugías abiertas abdo/torácicas altas que gatillan intenso dolor parietal y restrictivo a la excursión torácica (asociando secundariamente focos de atelectasias/neumonías masivas agudas). - **Máximo Riesgo Emético de Pabellón:** Son favorecedores y de alto impacto causante en náuseas pos-quirúrgicas: Pertener al género Mujer, antecedentes históricos personales de sufrir Mareos Cinetóticos recurrentes crónicos fáciles, uso peri-operatorio recetado de un opioide como rescate o analgesia, y muy peculiarmente, el ser rotundamente un "No-fumador".

Complicaciones de Pabellón en el Manejo de Cuidados de Vía Aérea

La causalidad médica imperativa y mayor de mortalidad, secuelas terminales asociativas y daño global orgánico crónico tras procedimientos de Anestesia es invariablemente el **Fracaso y descontrol al acceso del soporte de la Vía Aérea** o hipoxias de intubación.

- **Intubación Difícil y Anomalías Estructurales Macroscópica:** Alteración a su paso pernicioso tras una laringoscopia experimentada y técnica fallida por estrechec anatómica. Marcadores prequirúrgicos para desconfiar en pabellón:
- - Índice Mallampati III y IV o Cormack altos en laringoscopias pasadas (paladares blandos desproporcionados obstruyendo por lengua e impidiendo visión a luz glótica).
- - Cuellos rígidos, cortos gruesos u obesidades mórbidas masivas, más incisivos bucales dominantes gigantes que asimilan en proporción a piezas maxilares micrognatías limitadas del cráneo.
- **Factores Agregados a una Ventilación Difícil a bolsa simple conectada:** Uso previo documentado por neoplasias pasadas de radiaciones con Radioterapia en campos en cuello crónico (tejidos inamovibles fibrosos fibróticos que impiden los sellos herméticos perimetrales). Carentes de dientes funcionales o la masiva obesidad paralela.

Alternativas Salvoconductas y Vías Supraglóticas

- Los anestelistas evitan tragedias usando complementos técnicos de alivio en las Vías Estrechas y Difíciles puras:
- **Máscara Laríngea / Tubo Fast-Track Moderno:** Elemento supra-glótico de resguardo primario extremadamente sencillo y veloz su uso ciego. Gran contra a no considerar: Su embudo estructural se proyecta pero el sello traqueo-faríngeo dista de ser absoluto y esofágico al 100%. Por ende, **NO logra brindar ninguna protección contra los flujos de retorno biliar o una aspiración a faringe y traquea**, estando totalmente contraindicadas ante pacientes con contenido alimentario basal asediando gástricamente.

Concepto EUNACOM: El Asedio Gástrico Mortal de Pabellón (Estómago Lleno / Vómito).

- La urgencia quirúrgica requiere maniobras anestelistas en un tubo alimentario sin preparar, desatando la peor pesadilla anestésica el **Módulo de Aspiración Pulmonar Aguda grave de jugos gástricos ácido / Síndrome de Mendelson por contenido broncoaspirativo.**

- Se asume médicamente de base e inapelable que un individuo conforma y ostenta el riesgo inminente de un **Estómago Lleno** bajo las siguientes y definitivas de Pabellón en general pre concebidas directas:
- 1. No haber concretado y cruzado la barrera ineludible de las rigurosas **8 Horas mínimas absolutas ininterrumpidas de ayuno estricto pre operatorio**.
- 2. Todas y cada una de las cirugías provenientes de las casillas en un campo etiquetadas globalmente como urgencias agudas quirúrgicas abdominal y peri generales en sí; aunque la bitácora alimenticia declarada y las horas marcadas superaran los límites presuntamente o la anamnesis verbal sea correcta de inanición (un íleo infeccioso retrógrado y de estasis peritoneal gástrica en las urgencias viscerales de abdomen, anulan toda digestión basal logrando atasques en tramos gástricos distales).

Secuencia de Intubación Neumática Rápida (SIR / Crash Induction)

Como el Estómago Lleno no permite manipular gentil y largamente ni ventilar ni llenar la faringe a bolsa conectada manual debido a la temida hiperinflación de los esfínteres dilatantes gástricos provocando vómito forzado, **se realiza obligatoriamente esta técnica directa veloz:**

Pilar 1 Vital e insuperable previo ineludible: LA PREOXIGENACIÓN PASIVA al 100% de fracción externa a flujos masivos minutos a la máscara basal de alto calibre logrando empapar y barriendo nitrógeno de un volumen pulmonar funcional a saturaciones prolongadas periféricas por espacio de casi tres minutos para brindarle al Médico largos apneas. A continuación de su sedación fulminante endovenosa en seguidilla sin mediaciones (con el hipnótico paralizante muscular), se cursa inmediatamente con la canalización instrumental y el manguito oro-traqueal con tubo endotraqueal ocluyendo definitivo al instante rápido a boca, prescindiendo para siempre del uso ventilado o inflado manual a presión que arremetería inflando presiones intra viscerales insoportables estomacales directas en el cardias.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un paciente de sesenta años toma aspirina, metformina, atorvastatina y enalapril. Va a ser operado de una hernia inguinal electiva en cinco días. ¿Qué medicamento debe suspender?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Anestesia I. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Los medicamentos que se suspenden antes de la cirugía son anticoagulantes orales y antiagregantes cinco a siete días antes, y AINEs dos días antes; el resto se mantiene.
- La clasificación ASA va del uno al cinco: ASA uno es sano, ASA dos tiene enfermedad compensada, ASA tres tiene daño a órgano blanco, ASA cuatro tiene riesgo vital, ASA cinco es moribundo.
- Los mayores riesgos cardiovasculares son insuficiencia cardíaca severa, infarto de menos de seis meses y estenosis aórtica; el mayor riesgo respiratorio es el EPOC.
- La anestesia general se da con gases halogenados o endovenosa; la regional incluye peridural, espinal y bloqueos de plexos; la local se infiltra en los tejidos; todas usan anestésicos locales.
- La causa más frecuente de morbilidad anestésica es la pérdida de la vía aérea, seguida del error en la administración de fármacos.
- La máscara laríngea es fácil de instalar pero no protege de la aspiración, por lo que no se usa en estómago lleno; el fast track permite intubación a través de ella.
- En estómago lleno se usa secuencia de intubación rápida: preoxigenar, no ventilar, comprimir cricoides e intubar; el trauma facial contraindica la intubación nasal.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ANESTESIA I)**PREGUNTA 1**

Un paciente de sesenta años toma aspirina, metformina, atorvastatina y enalapril. Va a ser operado de una hernia inguinal electiva en cinco días. ¿Qué medicamento debe suspender?

- A)** Suspender todos los medicamentos cinco días antes
- B)** Suspender solo la aspirina cinco días antes
- C)** Suspender la metformina y la atorvastatina pero mantener la aspirina
- D)** No suspender ningún medicamento porque son todos crónicos
- E)** Suspender el enalapril para evitar hipotensión durante la anestesia

PREGUNTA 2

Un paciente de setenta y cinco años con insuficiencia cardíaca clase tres, insuficiencia renal crónica con creatinina de tres y diabetes descompensada va a ser operado de urgencia. ¿Cuál es su clasificación ASA?

- A)** ASA dos porque tiene enfermedades crónicas
- B)** ASA tres porque tiene enfermedades crónicas con daño a órgano blanco
- C)** ASA cuatro porque tiene riesgo vital inmediato
- D)** ASA uno porque está compensado para la cirugía
- E)** ASA cinco porque probablemente no sobrevivirá la cirugía

PREGUNTA 3

Un paciente politraumatizado llega a urgencias con trauma facial grave y fractura de mandíbula. Necesita intubación de urgencia. ¿Cuál es la contraindicación y la conducta?

- A)** Contraindicada la intubación orotraqueal; usar mascarilla laríngea
- B)** Contraindicada la intubación nasal por riesgo de fractura de lámina cribosa; usar secuencia de intubación rápida orotraqueal
- C)** Sin contraindicaciones; intubar por nariz que es más fácil en trauma facial
- D)** Contraindicada la anestesia general; usar anestesia regional
- E)** Contraindicada toda intubación; traquetomía de urgencia

RESUMEN: ANESTESIA I

La evaluación preanestésica tiene como objetivo evaluar y minimizar los riesgos, evaluar la vía aérea y elegir el tipo de anestesia y fármacos. Se realiza con anamnesis y examen físico completo. Los medicamentos que deben suspenderse antes de la cirugía son los anticoagulantes orales y los antiagregantes plaquetarios, incluyendo aspirina, entre cinco y siete días antes, y los AINEs dos días antes. El resto de los fármacos como los de hipertensión, diabetes y dislipidemia se mantienen. La clasificación ASA va del uno al cinco: ASA uno es sano; ASA dos tiene enfermedad crónica compensada sin daño a órganos; ASA tres tiene daño a órgano blanco o enfermedad descompensada; ASA cuatro tiene riesgo vital; ASA cinco es moribundo. El riesgo cardiovascular más alto lo tiene la insuficiencia cardíaca severa, el infarto de menos de seis meses y la estenosis aórtica; el respiratorio más alto es el EPOC. Los tipos de anestesia son general, regional y local. La anestesia general puede administrarse con gases halogenados o por vía endovenosa con inductor más relajante muscular más analgésico. La anestesia regional incluye peridural, espinal o raquídea, y bloqueos de plexos nerviosos; todas usan anestésicos locales como la bupivacaína. La anestesia local infiltra directamente los tejidos. La anestesia general y la espinal tienen el mismo riesgo de mortalidad. La laparoscopia tiene menor morbilidad que la cirugía abierta. La causa más frecuente de morbilidad asociada a la anestesia es la pérdida de la vía aérea, seguida del error en la administración de fármacos. La intubación difícil se define por la dificultad de instalar el tubo orotraqueal por persona experimentada; los factores de riesgo son la desproporción entre partes blandas y partes óseas, cuello rígido, y se evalúa con los índices de Cormack y Mallampati. La ventilación difícil es la dificultad de mantener saturación mayor al noventa por ciento. El manejo de vía aérea difícil incluye la máscara laríngea que no protege de aspiración, y el fast track que permite intubación a través de ella. En estómago lleno se usa la secuencia de intubación rápida: preoxigenar, no ventilar, comprimir cricoides e intubar.